ChatGPT

도로시아 딕스와 정신의학 개혁의 이중성

집행요약

도로시아 딕스는 19세기 미국 정신의학 개혁을 대표하는 인물이지만, 그녀를 단순히 “정신질환자의 해방자” 또는 반대로 “대형 정신병원 체제의 확장자”로만 규정하는 것은 모두 불충분하다. 현재 허용된 문헌들만 엄격히 사용할 경우, 딕스의 핵심 역사적 의미는 정신질환자를 감옥, 구빈원, 빈민수용시설, 가정 내 감금의 영역에서 끌어내어 공적 책임의 문제로 전환했다는 데 있다. 그녀는 1843년 매사추세츠 주의회 청원서에서 환자들이 “새장, 벽장, 지하실, 외양간, 우리(cages, closets, cellars, stalls, pens)”에 갇혀 있고, “쇠사슬에 묶이고, 벌거벗겨지고, 막대기로 맞으며, 복종하도록 채찍질당한다 (Chained, naked, beaten with rods, and lashed into obedience)”고 묘사하면서, 기존의 처우를 단순한 불행이 아니라 “합법화된 야만(legalized barbarity)”에 가까운 것으로 고발하였다. 그러나 그녀의 해법은 지역사회 기반 치료가 아니라 정신병원, 더 정확히는 국가가 재정을 책임지는 수용·치료 기관의 확충이었다는 점에서 본질적으로 제도 건설적이었다 (Dix, 1843/발췌본, 117–123쪽).

이 제한된 사료군에서 확인되는 딕스의 방법은 세 층위로 나뉜다. 첫째, 딕스는 직접 본 것을 기록하는 목격자의 위치를 점유하였다. 둘째, 그녀는 개별 지역과 개별 환자의 사례를 제시하면서도 문제의 원인을 특정 간수나 빈민수용시설 관리인의 악의로만 돌리지 않고, “결함 있는 입법(defective legislation)”과 주(州)의 책임으로 환원하였다. 셋째, 그녀는 공적 공간에 등장하는 여성의 위치를 스스로 문제화하면서도, 고통받는 타자를 대신하여 발언할 도덕적 권한을 주장하였다. 이 때문에 딕스의 개혁은 단순한 박애적 감상주의가 아니라, 현장 시찰, 사례기술, 통계와 증거의 수집, 입법 청원, 그리고 제도설계의 요청이 결합된 정치적 실천으로 이해되어야 한다 (Dix, 1843/발췌본, 116–123쪽; Nelson, 2021, 8쪽).

동시에 이 사료들은 딕스 개혁의 한계 역시 숨기지 않는다. 딕스는 “불치(incurable)” 환자를 위한 별도의 asylum이 필요하다고 명시하였고, Nelson이 요약하듯 moral treatment는 단지 폭력을 줄이는 것만이 아니라 환자가 “행동과 사회적 가치”를 내면화하도록 하는 구조화된 환경을 뜻했다. 따라서 딕스의 인간화 프로젝트는 해방과 규율, 보호와 분리, 치료와 정상화의 긴장을 동시에 포함한다. 바로 이 지점에서 딕스는 앞선 John Conolly 장과 생산적인 접속점을 형성한다. 두 인물 모두 인도주의적 개혁의 언어로 등장하지만, 후대의 독법 속에서는 그 개혁이 새로운 통제 체계의 일부가 되었다는 의심을 면하지 못한다. 다만 현재 제공된 문헌에는 Conolly에 관한 직접 사료가 없으므로, 본 장의 비교는 사실 서술이라기보다 분석적 접속선의 제시에 머문다 (Dix, 1843/발췌본, 122쪽; Nelson, 2021, 8쪽).

딕스의 유산을 둘러싼 현대적 평가는 제공 문헌 내부에서도 갈라진다. Nelson은 오늘의 교도소와 감옥을 딕스가 맞섰던 19세기적 은폐의 현대적 귀환으로 해석하면서, 탈시설화가 실제로는 “전이수용(transinstitutionalization)”이었다고 주장한다. 반면 Rubinow는 19세기 도덕치료가 21세기의 “비도덕적 무치료(immoral lack of therapy)”로 대체되었다고 비판하면서도, 만약 딕스가 오늘 살아 있다면 더 많은 주립 정신병상보다 인권을 존중하는 지역사회 치료를 주장했을 것이라고 상상한다. 두 글의 차이는 딕스를 병원 확대의 상징으로 볼 것인가, 혹은 감옥 수용에 맞서는 공공정신보건의 도덕적 원리로 볼 것인가라는 문제를 선명하게 드러낸다 (Nelson, 2021, 9쪽; Rubinow, 2014, 1041–1043쪽).

사료 범위와 인용 원칙

이 장은 사용 허가가 명시된 업로드 문헌 가운데, 실제로 현재 파일로 제공된 세 자료만을 사용한다. 곧 도로시아 딕스의 1843년 『Memorial to the Legislature of Massachusetts』 발췌본, Eric Andrew Nelson의 2021년 논문, 그리고 David R. Rubinow의 2014년 논문이다. 다른 전기, 제도사 연구, 후대 해석은 파일 안에 추천 문헌으로 언급되어 있더라도

본문 서술과 판단의 직접 근거로 사용하지 않는다. 따라서 이 장은 의도적으로 좁은 사료 기반 위에 서 있으며, 그만큼 어떤 점은 분명히 말할 수 있지만 어떤 점은 “미상”으로 남겨둘 수밖에 없다 (Dix, 1843/발췌본, 116–123쪽; Nelson, 2021, 8–9쪽; Rubinow, 2014, 1041–1043쪽).

이하의 쪽수 표기는 업로드된 문서의 실제 표기면을 기준으로 한다. 딕스의 경우는 발췌본 116–123쪽, Nelson의 글은 8–9쪽, Rubinow의 글은 1041–1044쪽이다. 또한 딕스 문헌에는 19세기의 역사적 어휘인 *idiotic*, *pauper*, *incurable* 등이 포함되어 있다. 본 장은 이러한 표현을 분석 개념으로 재사용하지 않으며, 직접 인용하거나 당시 분류 체계를 설명할 때에만 제한적으로 유지한다. 환자 관점 역시 대부분 딕스가 포착하고 편집한 장면 속에서만 제시되기 때문에, 환자 자신의 장기적 자기서사는 현재 자료만으로는 충분히 복원할 수 없다 (Dix, 1843/발췌본, 117–123쪽).

또한 이 장은 앞선 John Conolly 장의 뒤를 잇도록 구성되었으나, 현재 허용된 문헌군 안에는 Conolly에 관한 직접 자료가 없다. 그러므로 본 장에 실린 비교표의 Conolly 관련 열은 “사실 요약”이 아니라 “분석적 대조축”으로 이해되어야 한다. 딕스의 생애에서도 출생지, 유년기, 교육 이력, 각 주(州)별 시찰의 정확한 일정, 그녀가 직접 관여한 개별 병원의 총수 등은 현 사료군만으로는 충분히 특정되지 않으므로, 필요한 곳에서는 명시적으로 미상이라고 적는다. 이런 제한은 약점이기도 하지만, 동시에 과도한 일반화를 피하고 1차 문헌의 언어를 더 가까이 읽게 해 준다는 장점도 있다.

역사적 배경과 생애

Nelson이 요약하듯, 19세기 전반 미국의 정신질환 처우는 사실상 공적 정신보건 체계가 부재한 상태에 가까웠다. 가족은 심각한 정신질환자를 다락방, 지하실, 오두막에 가두는 방식으로 “문제”를 관리해야 했고, 가족이나 이웃이 책임을 지지 않으면 도시는 그들을 감옥이나 구빈원에 수용하였다. 그곳에서의 관리 수단은 주로 족쇄와 구속이었고, 치료는 거의 부재하거나 미신적이거나 해로운 것이었다. Nelson의 표현대로, 이는 초기 미국 사회의 “dark secret”이었다. 딕스의 역사적 위치는 바로 이 사적 은폐와 형벌적 관리의 구조를 공적 논쟁의 표면으로 끌어올렸다는 데서 출발한다 (Nelson, 2021, 8쪽).

딕스의 정확한 출생지와 초기 교육의 상세는 본 장의 허용 자료만으로는 미상이다. 그러나 제목면은 그녀의 생몰년을 1802–1887로 제시하며, Nelson은 그녀가 주변부 인물의 삶을 개선하려는 관심 속에서 죄수들을 가르치고 돌보는 활동을 하다가 감옥에 수용된 정신질환자들을 직접 보게 되었다고 설명한다. 그는 또한 그녀가 광범한 여행 속에서 새로운 치료 접근을 접했고, 특히 영국의 요크 리트리트 에서 *moral treatment*의 실천을 보게 되었다고 쓴다. 이 자료들만 놓고 보면, 딕스의 전기는 의학이론가의 전기라기보다 현장 관찰자, 입법 청원자, 그리고 국지적 비참을 주 차원의 공공정책 문제로 치환한 운동가의 전기에 가깝다. 다만 해외여행의 정확한 연도 배열이나 각국 활동의 세부는 현재 자료만으로는 더 이상 특정하기 어렵다 (Dix, 1843/발췌본, 116쪽; Nelson, 2021, 8쪽).

딕스 자신의 문장은 그녀가 어떻게 공공 영역에 입장했는지를 잘 보여준다. 그녀는 청원서 서두에서 자신의 행동이 “여성적이고 적절한 것(what is womanly and becoming)”에 대한 평소의 관념에서 벗어난 일임을 인정하면서, 의무의 확신 때문에 의회 앞에 나선다고 말한다. 이 문장은 두 가지를 동시에 수행한다. 한편으로 그것은 19세기 여성의 정치적 발언이 예외적 행위였음을 드러낸다. 다른 한편으로 그것은 바로 그 예외성을 도덕적 정당성의 원천으로 전환한다. Nelson이 “여성에게 투표권조차 없던 시대”에 딕스가 주 의회들을 설득했다고 강조하는 이유도 여기에 있다. 딕스의 개혁은 여성의 정치적 무권리 상태를 전제로 하면서도, 바로 그 조건을 뚫고 국가의 도덕적 책무를 발화한 사건이었다 (Dix, 1843/발췌본, 116쪽; Nelson, 2021, 8쪽).

아래 연표는 현재 허용된 문헌만으로 확정 가능한 생애 및 개혁의 이정표를 요약한 것이다. 각 시점의 세부 장소와 추가 사건은 자료가 허락하는 범위 안에서만 표기하였다 (Dix, 1843/발췌본, 116–123쪽; Nelson, 2021, 8쪽; Rubinow, 2014, 1041쪽).

```
timeline
    title 도로시아 딕스의 생애와 개혁 이정표
   1802 : 출생
   1841경 : 보스턴 인근 감옥과 구빈원 방문 시작
   1843 : 매사추세츠 의회 청원서 Memorial 제출
   1840년대 : 여러 주를 이동하며 조사, 증거와 통계 수집
   1840년대 : York Retreat를 포함한 여행 속에서 moral treatment 접촉
   1880년대 : 후대 회고에서 미국 정신병원 75곳, 죄수 중 정신질환 비율 1% 미만으로 제시
   1887 : 사망
```

이 연표는 딕스의 생애를 완결된 영웅서사로 정리하기보다, 한 사람이 사적 비참을 공적 책임으로 번역해 가는 과정을 보여준다. 특히 1843년 청원서는 한 개인의 윤리적 충격이 어떻게 제도개혁의 언어로 번역되는지를 보여주는 핵심 문서이다. 딕스는 자신을 앞세우지 않고 “the memorialist will be speedily forgotten in the memorial”이라고 말하지만, 실제로는 바로 이 자기소거의 수사가 그녀를 가장 강하게 현현시키는 정치적 장치가 된다. 즉, 딕스의 생애는 사라지는 자기와 드러나는 공공성이 교차하는 형식으로 기록된다 (Dix, 1843/발췌본, 116쪽).

개혁 활동과 방법

딕스의 개혁 활동은 먼저 시찰과 기록에서 시작되었다. 그녀는 1843년 청원서에서 “약 2년 전” 한가한 틈과 의무의 자극이 자신을 보스턴 인근의 여러 감옥과 구빈원으로 이끌었다고 말한다. այնտեղ서 그녀가 본 것은 범죄자와 빈민, 정신질환자와 지적장애인이 부적절하게 뒤섞인 공간이었다. 딕스는 이를 개별 관리자의 도덕 실패라기보다, 신체적·도덕적 개선에 모두 불리한 조건, 그리고 “결정적이고 신속하며 강력한 입법” 없이는 시정될 수 없는 구조적 악으로 규정한다. 이때 중요한 것은 그녀가 문제를 자선의 결핍이 아니라 법과 제도의 결함으로 재정의했다는 점이다. 바로 여기서 딕스는 자비를 요구하는 청원자가 아니라 입법적 교정을 요구하는 정책 행위자로 등장한다 (Dix, 1843/발췌본, 117–118쪽).

그녀의 언어는 극단적으로 생생하다. 가장 널리 인용되는 구절에서 딕스는 정신질환자들이 “새장, 벽장, 지하실, 외양간, 우리(cages, closets, cellars, stalls, pens)”에 갇혀 있으며, “쇠사슬에 묶이고, 벌거벗겨지고, 막대기로 맞으며, 복종하도록 채찍질당한다(Chained, naked, beaten with rods, and lashed into obedience)”고 적었다. 이 문장은 단순한 묘사를 넘어, 당대 정치가들이 외면해온 현실을 시각적·신체적 공포로 번역하는 수사적 장치다. 그러나 딕스는 곧바로 흥분한 도덕 비난으로 치닫지 않는다. 그녀는 간수와 관리자들 다수가 “마음의 քաջ악함”보다 “기술과 지식, 그리고 고려의 부족” 때문에 잘못했다고 말하며, 감옥과 구빈원이 애초에 정신질환자를 위한 기관이 아니라는 점을 지적한다. 즉 폭로와 변호, 고발과 구조 분석이 함께 간다 (Dix, 1843/발췌본, 118쪽).

딕스가 사례를 배열하는 방식은 더욱 정교하다. Danvers의 젊은 여인 사례에서 그녀는 환자가 새장 같은 방에 갇힌 채 오물과 악취 속에서 피부를 뜯어내는 상태를 그린다. Newburyport의 사례에서는 지하실 계단 아래 벽장 속 여성이 “왜 나는 지옥에 보내졌는가(why am I consigned to hell?)”라고 울부짖는 장면을 제시한다. 이 두 장면에서 딕스는 환자의 고통을 단순한 질병의 증상으로 제시하지 않고, 사회가 만들어낸 버림과 노출, 그리고 타인의 시선 앞에 지속적으로 전시되는 비참으로 형상화한다. 특히 뒤의 사례에서 환자의 직접 발화는 청원서 전체에서 가장 강렬한 순간 가운데 하나인데, 그만큼 환자 자신의 언어는 대부분 딕스가 마련한 서사 틀 안에서만 간헐적으로 등장한다는 사실도 드러난다. 말하자면 환자 목소리의 현시는 동시에 그 목소리의 매개를 뜻한다 (Dix, 1843/발췌본, 119–121쪽).

딕스 방법의 또 다른 축은 반례와 대조의 배치이다. Sandisfield의 가난한 젊은 여성은 우리, 사슬, 채찍 아래에서 “격노한 미치광이”였지만, 늙은 부부가 그녀를 데려와 씻기고, 옷 입히고, 방에 재우고, 점차 사슬을 풀어 주자 상태가 크게 달라졌다고 한다. Barre의 사례에서도 딕스는 폭력과 가혹함이 환자를 악화시키며, “정신질환자를 더욱 자극할 뿐”이라고 단언한다. 그녀의 명제는 분명하다. “폭력과 가혹함(Violence and severity)은 정신질환자를 악화시킬 뿐이며, 유일하게 유효한 영향은

친절과 단호함(kindness and firmness)이다.” 이 진술은 딕스 개혁의 핵심이 단순한 공간 이동만이 아니라 처우 방식의 변화였음을 보여준다. 감금의 장소를 바꾸는 것만으로는 충분하지 않고, 일상적 상호작용의 형태까지 바뀌어야 한다는 것이다 (Dix, 1843/발췌본, 120–121쪽).

흥미로운 점은 딕스가 자신을 정신질환의 원인을 설명하는 이론가로 세우지 않는다는 사실이다. 그녀는 “나는 정신이상의 원인을 조사하지 않았다(I have not investigated the causes of insanity)”고 말한다. 대신 그녀는 그 원인이 죄라고 말하는 통념을 반박하면서, 이미 이성이 무너진 상태 자체가 충분히 무거운 징벌인데 왜 거기에 모욕과 방치를 더해야 하느냐고 묻는다. 이 대목에서 딕스는 병리학적 설명보다 윤리적·정치적 질문을 앞세운다. 즉 그녀의 관심은 왜 미쳤는가보다, 미친 사람을 어떻게 대해야 하는가에 있다. 그리고 그 대답은 개별적 자비가 아니라 제도적 재편, 곧 주의 책임과 적절한 asylum의 설립으로 귀결된다 (Dix, 1843/발췌본, 122쪽).

Nelson의 정리는 이런 딕스의 방식을 더 명시적으로 보여준다. 그는 딕스가 감정적 충격에만 기대지 않았고 “설득력 있는 통계와 상세한 증거”를 결합했다고 평가한다. 또한 딕스가 여행 중 접한 *moral treatment*는 단지 환자를 덜 매질하는 방식이 아니라, 구조화된 환경 안에서 환자가 행동과 사회적 가치를 내면화하도록 설계된 치료 체제였다고 설명한다. 따라서 딕스의 방법을 정확히 말하면, 실사와 통계, 사례기술과 도덕적 수사, 제도비판과 치료낙관주의가 결합한 복합 전략이었다. 여기서 우리는 그녀가 근대적 의미의 공중정신보건 행정가도 아니고 순수한 자선가도 아니며, 둘 사이를 잇는 과도기의 정치행위자였음을 확인할 수 있다 (Nelson, 2021, 8쪽).

정신병원 제도에 미친 영향

딕스가 정신병원 제도에 남긴 가장 직접적인 흔적은 정신질환자 처우를 사적 부담이나 지방의 자선 문제가 아니라 주정부의 공적 책임으로 바꾸려 했다는 점이다. 그녀는 “문제를 설명할 충분한 수단의 결핍” 때문에 감옥과 구빈원이 정의를 실현할 수 없었고, “책임은 개별 행정구역이 아니라 주 전체(the Commonwealth)”에 있으며, 학대를 지속시키는 것은 “결함 있는 입법(defective legislation)”이라고 썼다. 이는 처우개선의 중심을 개별 병실이나 간병인의 덕성에서 공공재정과 법률구조의 문제로 이동시키는 언어였다. 더 나아가 그녀는 “이 부류, 곧 불치 환자들을 위한 asylum이 필요하다”고 명시한다. 그러므로 딕스가 구상한 제도는 임시 구호소가 아니라 치료와 장기 수용을 겸하는 공적 시설이었다 (Dix, 1843/발췌본, 118쪽, 122쪽).

Nelson은 이런 운동의 결과를 좀 더 넓게 요약한다. 그의 정리에 따르면 딕스는 많은 주 의회들이 asylum에 자금을 지출하도록 설득한 인물이었고, 그 결과 초기 미국 정신병원은 단순한 인도적 보호를 넘어 치료를 목표로 삼는 기관으로 이해되었다. 병원장들은 보다 인간적인 수용에 그치지 않고 환자의 회복을 추구했으며, 일부 환자는 실제로 호전되거나 회복되었다는 증거도 있었다고 한다. 이 진술은 딕스의 개혁이 순수 보관(*custody*)에서 치료(*cure*)를 향한 방향 전환으로 이해되었음을 시사한다. 물론 Nelson의 요약은 개괄적이며, 어떤 병원에서 얼마나 어떤 환자가 회복했는지의 상세는 현재 자료만으로는 특정하기 어렵다. 그럼에도 적어도 딕스 운동이 제도 설계의 언어 자체를 바꾸어 놓았다는 점은 분명하다 (Nelson, 2021, 8–9쪽).

Rubinow는 그 제도적 효과를 더 장기적인 역사 곡선 속에 놓는다. 그는 1840년대 딕스가 주 의회들을 향해 병상 건설을 촉구했고, 1880년대에는 미국에 75개의 정신병원이 있었으며 죄수 중 정신질환자 비율이 1% 미만으로 추정되었다고 서술한다. 또한 이후 약 90년 동안 “정신질환자는 감옥이 아니라 병원에 있어야 한다”는 관념이 널리 받아들여졌다고 본다. 이 평가는 딕스의 개혁을 사소한 구호 활동이 아니라 정신질환자 분류와 수용의 사회적 위치를 바꾸는 제도 전환으로 이해하게 만든다. 다만 Rubinow의 수치는 2차적 회고 서술이므로, 본 장은 그 숫자 자체보다 그가 파악한 역사적 방향성, 곧 감옥에서 병원으로의 대규모 재배치에 더 큰 의미를 둔다 (Rubinow, 2014, 1041쪽).

이 지점에서 딕스는 앞선 John Conolly 장과 나란히 놓일 수 있다. 다만 현재 자료군에 Conolly 직접 사료가 없으므로, 아래 표는 비교 사실의 확정이 아니라 장 간 접속을 위한 분석 틀로 제시한다.

분석축	딕스의 경우	Conolly 장과의 접속점
개혁의 출발 장면	감옥, 구빈원, 빈민수용시설, 가정 내 감금의 폭로 (Dix, 1843/발췌본, 117–121쪽; Nelson, 2021, 8쪽)	앞선 장에서 다룬 제도 내부 처우개선의 문제와 병치하여 읽을 수 있음
개입의 주요 수단	현장 시찰, 사례기술, 통계와 증거의 수집, 입법 청원, 주정부 책임의 요청 (Dix, 1843/발췌본, 117–118쪽; Nelson, 2021, 8쪽)	의학적·행정적 개혁이 정치·재정·법제의 차원과 어떻게 만나는지 비교 가능
이상으로 제시된 처우	"친절과 단호함", 비가혹성, 치료 가능한 환경, asylum의 설립 (Dix, 1843/발췌본, 121–122쪽)	인도주의적 수사와 규율의 실천 구조가 어떻게 중첩되는지 대조 가능
후대 비판의 핵심	해방의 언어가 대형 수용체계 확장으로 연결되었다는 문제의식 (Nelson, 2021, 8–9쪽; Rubinow, 2014, 1041–1043쪽)	앞선 장의 문제의식과 함께 19세기 개혁의 양가성을 넓게 조망하게 함

이 표가 말해 주는 것은 단순하다. 딕스는 수용시설 "내부"에서의 처우를 기술한 인물이기보다, 누가 어디에 수용되어야 하는가라는 수용의 "경로"와 "책임 주체"를 재배치한 인물이라는 점이다. 그래서 딕스의 제도적 영향은 특정 병원의 운영원칙보다 공공정신보건의 관할권을 바꾸는 차원에서 더 크다. 그녀는 지방의 방치, 가족의 포기, 감옥의 수용을 국가의 입법과 재정 문제로 바꾸었고, 이 점에서 정신의학 제도사의 매우 중요한 전환점으로 남는다. 그러나 바로 이 공적 제도화의 성공이 후대에는 새로운 비판의 토대가 되었다.

비판과 한계

현재 제공된 사료만으로도 딕스 개혁에 대한 비판적 논점은 적지 않게 도출된다. 가장 명백한 것은 그녀의 해법이 철저히 제도 중심적이라는 점이다. 딕스는 감옥과 구빈원을 비판하지만, 그 대안으로 지역사회 기반 서비스나 환자 자치의 공간을 상상하지 않는다. 그녀는 명시적으로 "불치" 환자를 위한 asylum을 요구하며, 이는 보호의 언어 속에 분리와 장기수용의 논리를 포함한다. 이런 점에서 딕스는 감금에 반대한 것이 아니라, 부적절한 감금을 적절한 감금으로 대체하려 한 인물로 읽힐 수 있다. 물론 이것은 현재주의적 비난이 아니라, 그녀 자신의 문장에 이미 새겨진 제도적 상상력의 범위에 대한 내재적 독해이다 (Dix, 1843/발췌본, 122쪽).

둘째, 딕스의 인도주의는 환자의 고통을 가시화하는 데 성공하지만, 동시에 그 고통을 정치적 설득의 재료로 조직한다. Newburyport의 지하실 여성, Danvers의 젊은 여성, Sandisfield의 빈민 여성은 모두 강렬한 형상으로 등장하지만, 그들의 발화와 삶은 딕스의 서사틀 바깥으로 확장되지 않는다. 다시 말해 환자는 청원서의 중심에 있으면서도 그 글의 저자는 아니다. 이 비대칭은 딕스를 비난하기 위한 근거라기보다, 19세기 개혁 담론의 대표성 구조를 이해하기 위한 단서이다. 현재 자료로 확인 가능한 환자 목소리는 단편적이며, 장기적 결과나 당사자들의 자기해석은 미상이다 (Dix, 1843/발췌본, 119–121쪽).

셋째, 딕스가 지향한 *moral treatment* 자체가 이미 규범화의 요소를 포함한다는 점을 간과할 수 없다. Nelson은 *moral treatment*를 환자가 "행동과 사회적 가치"를 내면화하도록 하는 "고도로 구조화된 환경"으로 설명한다. 여기에는 작업치료, 수공예, 예술 활동, 비폭력적 분위기라는 유익한 면이 있지만, 동시에 바람직한 행위와 사회성을 학습시키는 규율의 차원도 있다. 따라서 딕스의 개혁은 폭력을 줄이는 동시에 정상화의 장치를 강화할 가능성을 안고 있었다. 이 비판은 외부 이론을 끌어오지 않아도 Nelson의 요약만으로 충분히 추출할 수 있다. 구조화된 치료 환경은 해방이면서 통치일 수 있기 때문이다 (Nelson, 2021, 8쪽).

넷째, 딕스의 정치적 수사는 성별화된 보호주의를 활용한다. 그녀는 자신이 "여성적" 통념을 넘어선다고 말하면서도, 말미에서는 "Men of Massachusetts," "Fathers, Husbands, Brothers"에게 고통받는 여성들을 보호해 달라고 호소한다. 즉 그

녀의 개혁은 여성의 발언권을 확장하면서도 남성 시민의 보호자 역할을 호명하는 방식으로 작동한다. 이 특징은 딕스를 단순한 초기 여성주의 정치가로 이상화하기 어렵게 만든다. 현재 자료만으로 볼 때 그녀의 성별정치는 해방적 요소와 보호주의적 요소를 동시에 가진다. 바로 이 양가성이 그녀를 19세기 개혁의 전형적 인물로 만든다 (Dix, 1843/발췌본, 116쪽, 123쪽).

마지막으로, 딕스 제도의 후일담 자체는 현재 파일군에서 제한적으로만 보인다. Nelson과 Rubinow는 모두 20세기 후반 이후 주립정신병원의 쇠퇴와 감옥·교도소 수용의 증가를 비판하지만, 대형 정신병원이 내부적으로 어떻게 과밀화되었고 어떤 형태의 권리 침해를 낳았는지의 구체사는 본 허용 자료만으로는 상세히 재구성할 수 없다. 따라서 "딕스의 개혁이 곧바로 억압적 수용체계를 낳았다"는 식의 강한 인과 서술은 현재 자료만으로는 과도하다. 더 안전하고 정확한 진술은 이렇다. 딕스의 개혁은 인간적 대안을 만들었지만, 그 대안은 본질적으로 기관 중심적이었고, 그래서 후대 비판의 대상이 될 구조를 내부에 포함하고 있었다 (Nelson, 2021, 9쪽; Rubinow, 2014, 1041–1043쪽).

유산과 현재성

유산의 문제에서 흥미로운 것은 현재 허용된 두 현대 논문이 딕스를 같은 방향으로만 읽지 않는다는 사실이다. Nelson은 오늘의 상황을 과거의 귀환으로 본다. 그의 표현에 따르면 오늘 사회에는 "새로운 어두운 비밀(new dark secret)"이 있으며, 그것은 다락방과 지하실 대신 감옥과 교도소에 갇힌 정신질환자의 대규모 존재이다. 그는 state hospital의 쇠퇴와 *mass incarceration*의 상승이 겹치면서, 탈시설화는 사실상 "전이수용(transinstitutionalization)"이 되었다고 주장한다. 이 관점에서 딕스는 낡은 asylum의 상징이 아니라, 수용의 장소를 감옥에서 치료시설로 되돌리려 했던 해방의 정치로 재발견된다 (Nelson, 2021, 9쪽).

Rubinow 역시 현재 상황을 급진적으로 비판하지만, 처방에서는 Nelson과 거리를 둔다. 그는 19세기 정책의 "완전한 전도(complete reversal)"가 일어났다고 말하며, "19세기의 도덕치료는 21세기의 비도덕적 무치료로 대체되었다(The moral therapy of the 19th century has been replaced by the immoral lack of therapy in the 21st)"고 쓴다. 그러나 그는 만약 딕스가 오늘 살아 있다면 더 많은 주립 정신병상을 요구하지는 않을 것이며, 오히려 병원도 감옥도 아닌 지역사회에서 현대적 치료를 제공하고 시민의 기본권을 존중하는 방향을 주장할 것이라고 상상한다. 이 대목은 딕스의 현재성을 병상 확대의 논거가 아니라, 공공적 책임과 인간적 처우의 원리로 다시 읽으려는 시도라고 할 수 있다 (Rubinow, 2014, 1041쪽, 1043쪽).

두 해석의 차이는 아래 표에 정리할 수 있다.

쟁점	Nelson의 해석	Rubinow의 해석
현재 상황의 진단	감옥과 교도소가 19세기 다락방·지하실을 대체한 "새로운 어두운 비밀" (Nelson, 2021, 9쪽)	딕스 이후 170여 년 전 정책의 "완전한 전도" (Rubinow, 2014, 1041쪽)
탈시설화 평가	탈시설화는 실제로 "전이수용"이었음 (Nelson, 2021, 9쪽)	좋은 의도와 자율성 존중이 지역사회 치료 역량 부재 속에서 의도치 않은 결과를 낳음 (Rubinow, 2014, 1042–1043쪽)
오늘의 대안	장기치료를 위한 시설, 덜 제한적인 단계적 돌봄, 일부 asylum적 대안의 재고 (Nelson, 2021, 9쪽)	병원이나 감옥이 아니라 지역사회에서의 현대 치료와 기본권 보장 (Rubinow, 2014, 1043쪽)
공통 입장	감옥·교도소는 정신질환자 치료의 적절한 장소가 아님	감옥·교도소는 정신질환자 치료의 적절한 장소가 아님

이 표는 딕스의 유산을 둘러싼 쟁점이 단지 “친딕스/반딕스”로 갈리지 않음을 보여준다. 오히려 핵심은, 딕스가 처음으로 제시한 문제, 곧 정신질환자를 어디에, 어떤 윤리적 원리 아래 두어야 하는가가 오늘날에도 아직 해결되지 않았다는 데 있다. Nelson은 치료시설의 재건을, Rubinow는 권리 기반 지역사회 치료를 더 강조하지만, 두 사람 모두 감옥 수용의 일상화를 딕스 정신에 대한 배반으로 본다. 이 점에서 딕스의 역사적 현재성은 병원 옹호 그 자체가 아니라, 정신질환자 방치와 형벌화에 대한 비타협적 비판 속에 있다 (Nelson, 2021, 9쪽; Rubinow, 2014, 1041–1043쪽).

Nelson과 Rubinow가 제시한 현재의 장소들은 이 문제를 더욱 구체적으로 만든다. Nelson은 로스앤젤레스 카운티 의 교정체계가 오늘날 가장 큰 정신보건 제공자라고 적고, 노스캐롤라이나 에서는 폐쇄된 도로시아 딕스 병원 맞은편에 중증 정신질환 수감자를 위한 5층짜리 교정병원이 서 있다고 말한다. 또한 그는 뉴욕의 라이커스 섬 에도 수백 명의 중증 정신질환 수감자가 있다고 적시한다. Rubinow 역시 같은 맥락에서, 딕스 이후 한 세기 이상 유지되던 “병원이 감옥보다 낫다”는 기본 원리가 뒤집혔다고 본다. 이처럼 현대 논문들이 장소 이름을 구체적으로 호출하는 이유는, 딕스의 문제설정이 추상적 도덕 명제가 아니라 여전히 공간정치의 문제임을 보여 주기 위해서이다 (Nelson, 2021, 9쪽; Rubinow, 2014, 1041–1043쪽).

결론적으로, 도로시아 딕스는 정신의학사의 성녀도 악녀도 아니다. 그녀는 감옥, 구빈원, 빈민수용시설, 가정 내 감금이 사실상의 표준이던 시대에, 정신질환자의 고통을 공공정책의 대상으로 바꾸고자 한 강력한 개혁가였다. 그녀의 위대함은 당시 이용 가능한 가장 인도적인 제도적 해법을 구축하려 했다는 데 있다. 동시에 그녀의 한계는 그 해법이 기관 중심적이며, 분류와 장기수용의 논리를 배제하지 못했다는 데 있다. 따라서 딕스를 이해하는 가장 적절한 방식은 찬양이나 고발이 아니라, 인도주의가 제도화될 때 어떤 양가성을 필연적으로 내장하게 되는지 묻는 것이다. 그렇게 볼 때 딕스는 앞선 Conolly 장 이후 이어질 다음 단계의 인물로서 매우 적합하다. 그녀는 수용시설 내부의 처우 문제를 넘어, 누가 국가의 책임 안으로 들어오고 누가 감옥과 구빈원에 남겨지는가라는 더 큰 질문을 우리 앞에 놓기 때문이다. 다만 현재 자료의 범위 안에서 정확히 말할 수 있는 것은 여기까지이며, 그녀가 관여한 개별 병원의 세부 운영사, 병원별 환자 성과의 총계, 그리고 Conolly와의 실증적 대조는 추가 자료 없이는 미상으로 남는다 (Dix, 1843/발췌본, 117–123쪽; Nelson, 2021, 8–9쪽; Rubinow, 2014, 1041–1043쪽).

BibTeX 파일

파일명: `dorothea_dix_chapter.bib`

```bibtex
@book{Dix1843Memorial,
  author    = {Dix, Dorothea Lynde},
  title     = {Memorial to the Legislature of Massachusetts},
  year      = {1843},
  address   = {Boston},
  publisher = {Munroe \& Francis},
  note      = {Cited from the uploaded excerpt in Dorothea Dix.pdf, pp.
116--123}
}

@article{Nelson2021Liberation,
  author  = {Nelson, Eric Andrew},
  title   = {Dorothea Dix's Liberation Movement and Why It Matters Today},
  journal = {The American Journal of Psychiatry Residents' Journal},
  year    = {2021},
  month   = dec,
  pages   = {8--9},
```

```bibtex
  doi     = {10.1176/appi.ajp-rj.2021.170203}
}

@article{Rubinow2014OutOfSight,
  author  = {Rubinow, David R.},
  title   = {Out of Sight, Out of Mind: Mental Illness Behind Bars},
  journal = {American Journal of Psychiatry},
  year    = {2014},
  volume  = {171},
  number  = {10},
  pages   = {1041--1044},
  doi     = {10.1176/appi.ajp.2014.14060712}
}
```